



PROCEDIMENTO PADRÃO Nº 019

ÁREA MOTORA

FÁBIO COELHO



SUMÁRIO

1	ÁREA MOTORA	3
1.1	OBJETIVO GERAL	3
1.2	CAMPO DE APLICAÇÃO.....	3
1.3	FLUXO DO ATENDIMENTO	3
1.4	AVALIAÇÕES PADRONIZADAS	4
1.5	ELABORAÇÃO DO PDI	4
1.6	INTERVENÇÃO	5
1.7	REUNIÕES E INTEGRAÇÃO INTERDISCIPLINAR	5
1.8	INDICADORES DE QUALIDADE	5
1.9	RESPONSABILIDADES	6
1.10	<i>CHECKLIST</i> DE CONFORMIDADE SEMANAL	6
1.11	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	6



1 **ÁREA MOTORA**

1.1 **OBJETIVO GERAL**

Garantir que o atendimento fisioterapêutico ocorra de forma padronizada, mensurável e alinhada às melhores práticas clínicas, assegurando qualidade técnica e resultados efetivos para aprendizes com transtornos do neurodesenvolvimento.

1.2 **CAMPO DE APLICAÇÃO**

Aplica-se a todos os fisioterapeutas – nas áreas motora, aquática e respiratória – e aos respectivos Supervisores de Área que atuam na clínica.

1.3 **FLUXO DO ATENDIMENTO**

O atendimento fisioterapêutico segue as seguintes etapas:

- **Anamnese inicial:** Realizada pelo Supervisor Geral ou de Área, com registro na ficha de anamnese assinada, mediante a entrada do aprendiz na clínica.
- **Avaliação específica** (motora, aquática ou respiratória): Conduzida pelo fisioterapeuta responsável, com elaboração de relatório de avaliação em até 50 dias.
- **Elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI):** Realizada pelo fisioterapeuta, contendo os objetivos e estratégias individualizadas, no prazo máximo de 50 dias corridos.
- **Revisão e liberação do PDI:** Feita pelo Supervisor da Área Motora, com aprovação em até 3 dias.
- **Reunião de devolutiva com a família:** Conduzida pelo fisioterapeuta ou pelo Supervisor de Área, com registro em ata assinada, no prazo de até 60 dias.
- **Intervenção:** Sessões individuais de 40 minutos, registradas diariamente, abrangendo 100% dos atendimentos.



- **Reavaliação semestral:** Atualização do PDI e elaboração de relatório a cada 180 dias.
- **Alta** (quando aplicável): Conduzida pelo fisioterapeuta, com aprovação do Supervisor da Área e registro da alta no PDI em até 10 dias.

1.4 AVALIAÇÕES PADRONIZADAS

A etapa de avaliação é fundamental para direcionar o plano terapêutico com base em evidências. Todos os aprendizes devem ser avaliados com instrumentos adequados à modalidade de atendimento, garantindo precisão diagnóstica e padronização dos procedimentos.

- **Motora:** Utilização do IPO e da avaliação motora básica (postura, tônus, força, equilíbrio, coordenação e marcha).
- **Aquática:** Aplicação da avaliação de fisioterapia aquática (histórico, riscos, habilidades em solo e na água).
- **Respiratória:** Uso do protocolo de avaliação respiratória (tipo de respiração, ausculta, expansibilidade, frequência respiratória, frequência cardíaca, SpO₂, tosse e expectoração).
- **Indicador de qualidade:** 100% dos aprendizes devem ser avaliados com instrumentos padronizados e adequados à modalidade de atendimento.

1.5 ELABORAÇÃO DO PDI

O PDI deve conter, no mínimo, os resultados da avaliação, a linha de base, os objetivos observáveis e mensuráveis, as metas de curto, médio e longo prazo, as estratégias terapêuticas e os critérios de alta.



1.6 INTERVENÇÃO

A fase de intervenção é o momento de aplicação prática do planejamento terapêutico. Todas as ações devem seguir o PDI e as diretrizes do Modelo Academia do Autismo de Intervenção Singular (MAAIS), garantindo consistência técnica e foco nos objetivos funcionais do aprendiz.

- **Frequência:** Entre 1 e 4 sessões semanais, com duração de 40 minutos cada.
- **Configuração:** Atendimentos individuais.
- **Atividades em grupo/gincanas terapêuticas:** Permitidas apenas mediante plano previamente aprovado pelo Supervisor da Área Motora.
- **Registro:** Os dados devem ser inseridos no sistema eletrônico até 10 minutos após o término da sessão.

1.7 REUNIÕES E INTEGRAÇÃO INTERDISCIPLINAR

Os fisioterapeutas devem participar de discussões clínicas multidisciplinares (mínimo de uma hora), com registro em ata. Também devem comparecer às reuniões da equipe de fisioterapia, com documentação arquivada.

1.8 INDICADORES DE QUALIDADE

O monitoramento contínuo dos indicadores garante a eficiência e a qualidade do atendimento fisioterapêutico. Esses parâmetros permitem mensurar o desempenho técnico, a aderência aos protocolos e o impacto das ações no progresso do aprendiz.

- **Tempo para elaboração do PDI:** Até 50 dias após o início do atendimento (monitoramento mensal).
- **Evoluções registradas:** Mínimo de 98% das sessões com registro eletrônico (monitoramento semanal).
- **Reavaliações semestrais:** Cumprimento de pelo menos 95% das reavaliações previstas (monitoramento semestral).



1.9 RESPONSABILIDADES

O cumprimento das responsabilidades descritas aqui assegura a execução adequada dos atendimentos, a padronização das condutas clínicas e a comunicação eficiente entre as equipes.

- **Fisioterapeuta:** Realizar avaliações, elaborar o PDI, registrar evoluções, comunicar intercorrências e participar das reuniões clínicas. Deve elaborar relatório semestral de acompanhamento.
- **Supervisor da Área Motora:** Revisar e aprovar PDIs e relatórios; supervisionar a equipe; repassar treinamentos; e reportar resultados à Supervisão Geral. As reuniões devem ser registradas em atas arquivadas.
- **Supervisão Geral:** Acompanhar os indicadores da área, prover recursos, validar revisões dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) e emitir relatórios gerenciais periódicos.

1.10 CHECKLIST DE CONFORMIDADE SEMANAL

O *checklist* semanal deve incluir a verificação dos seguintes itens:

- A avaliação inicial foi iniciada em até 5 dias após a entrada do aprendiz?
- As evoluções estão 100% lançadas no sistema clínico?
- O PDI foi revisado e assinado pela família?

Em caso de não conformidade, devem ser adotadas ações corretivas imediatas, registradas pelo Supervisor da Área.

1.11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este POP orienta a prática fisioterapêutica no MAAIS, garantindo que todas as etapas – da avaliação à alta – ocorram de forma estruturada, ética e baseada em evidências.

A padronização dos processos fortalece a qualidade dos atendimentos, promove a integração interdisciplinar e assegura que cada aprendiz receba um cuidado individualizado, mensurável e alinhado aos princípios institucionais.



EQUIPE EDITORIAL

AUTORIA

Fábio Coelho

DIAGRAMAÇÃO E DESIGN GRÁFICO

Victor Cardoso

EDIÇÃO E REVISÃO DE TEXTO

Victor Cardoso

REVISÃO TÉCNICA

Hallana Faria

CONSULTORES E ESPECIALISTAS

Fábio Coelho

Jenifer Macedo

Maria Christina Souza

PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO

Academia do Autismo

REDES SOCIAIS



@maaisacademiadoautismo



@maaisacademiadoautismo



@academiadoautismo



@academiadoautismo

CONTATO



maais@academiadoautismo.com.br



(22) 99216-0282



academiadoautismo.com.br/maais

Este material é protegido por direitos autorais e não pode ser comercializado, distribuído, copiado, editado, alugado, transmitido ou reproduzido, total ou parcialmente, em qualquer meio de comunicação ou distribuição. Permissões para tais ações podem ser concedidas somente mediante autorização expressa do detentor e proprietário dos direitos do material. Qualquer violação dos direitos autorais estará sujeita a ações legais. Todos os direitos estão reservados à Academia do Autismo Ltda.